

권 고 사 항

1. 제 목 : 의료질 평가(적정성 평가) 및 감염관리에 관한 사항

2. 관계기관 : QQ이사, WW이사, 5개 병원

3. 내 용 : 병원에서는 공단 설립 목적에 맞게 국가유공자 및 유가족과 지역 주민에게 양질의 의료서비스를 제공하기 노력하고 있으며, 정부는 다양한 방법으로 병원의 서비스 질 향상을 위해 의료기관인증제 및 의료의 질¹⁾ 평가, 요양급여 적정성 평가 등으로 의료서비스의 질을 관리하고 있고, 또한 2015년 메르스와 유사한 사태를 예방하기 위하여 감염에 대한 정책도 강화하고 있습니다.

가. 의료질평가(적정성평가) 관련

^^원에서는 「국민건강보험법」 제63조에 따라 국민에게 의료기관 선택의 정보로 활용할 수 있도록 2000년도부터 매년 질병별, 약제급여 등 요양급여의 적정성 평가를 시행하고 홈페이지에 결과를 공개하고 있으며, 의료질평가지원금 수가를 신설하여 2015년 9월부터는 의료질에 대해 ① 의료 질 및 환자안전·공공성·의료전달체계, ② 교육수련, ③ 연구개발 3개 분야로 평가를 실시하고 결과에 따라 분야별로 1등급부터 3등급 또는 5등급까지 차등하여 수가를 지급하고 있습니다.

의료질 평가지표의 구성을 보면 요양급여의 적정성 평가를 포함하여 입원 환자당 의사수, 항생제 처방률, 주사제 처방률 등으로 시설인프라 개선 및 사전 모니터링을 통해 지속적으로 관리하여야만 평가결과가 향상될 수 있도록 구성되어 있습니다.

또한 [표 1]과 같이 2016.09.01.부터 수가가 대폭향상(의료질 환자안전 1등급의 경우 2,250원→4,000원, 78%증가)되었으나, 선택진료비 징수가 없는 의료기관의 경우는 소정점수의 50%로 산정되도록 개정되는 등 지표의 기준 및 적용이 상급종합병원 수준의 병원들에게 유리한 측면도 있습니다.

1) 의료의 질 : 국민에게 제공된 의료서비스가 기대하는 건강결과(Outcome)를 가져올 가능성을 높이고, 최신 경향의 전문적인 지식에 지속적으로 부합되는 정도

[표 1] 의료질평가지원금 수가

(단위 : 원)

구분		의료 질 및 환자안전 등					교육수련			연구개발		
		1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	1등급	2등급	3등급	1등급	2등급	3등급
입원	`15.09~`16.08	2,250	1,500	750	300	70	180	150	100	300	250	100
	`16.09~`17.08	4,000	3,600	2,400	300	70	1,550	800	100	900	610	100
외래	`15.09~`16.08	950	700	300	120	50	100	70	50	270	220	50
	`16.09~`17.08	1,250	1,000	800	120	50	500	260	50	290	220	50

의료질평가 평가지표 항목은 2015년 37개 항목에서 2016년 59개로 확대되었고 2017년에도 중환자실 감염 등 19개 지표가 추가될 예정이며, ^^원의 발간물 ‘2015년 요양급여 적정성 평가결과 종합보고서’에 따르면 향후 질병·수술중심에서 중증·만성질환 및 일반지표를 통한 기관단위 포괄평가로 확대·강화하는 것으로 계획하고 있습니다.

또한, 2016.07.29. 시행된 「환자안전법」 제12조에 따르면 일정 규모 이상의 병원급 의료기관은 환자안전 및 의료 질 향상에 관한 업무를 전담하여 수행하는 전담인력을 명시하여 의료 질 및 환자안전에 대해 체계적으로 관리하도록 법제화하였습니다.

따라서, 병원에서는 국가유공자의 의료서비스에 대한 질 향상과 환자의 안전 보장, 병원의 위상 제고뿐만 아니라 수익 증대 기여를 위해 중단기 계획을 수립하여 체계적으로 관리 할 필요가 있습니다.

그런데 5개 병원의 의료질 평가관리 부서 및 인원현황을 파악한 결과, [표 2]과 같이 @@병원을 제외하고는 4개 지방병원은 의료질 평가(QI)와 요양급여 적정성 평가(심사) 관리부서가 이원화되어 있으며, 전담 인원 부족 등으로 체계적인 관리가 되지 않고 있습니다.

[표 2] 평가 관리 부서 및 인원 현황

(단위 : 명)

구 분		@@병원	!!병원	##병원	\$\$병원	%%병원
의료질평가	부서	A부	B실	없음(TF운영)	B실	B실
	관리인원	1	1	-	2	1
요양급여 적정성 평가	부서	A부	C과	C과	C과	D과
	관리인원	1	심사업무별관리	심사업무별관리	심사업무별관리	심사업무별관리

[표 3]과 같이 @@병원의 경우는 일원화되어 운영하고 있음에도 불구하고 진료인원 및 병상규모 대비 적은 인원으로 체계적인 관리가 되지 않는 현실로 인해 ‘연구개발’은 ‘15년대비 1단계 하락하였으며, 지방병원의 경우는 C부서와 B실로 이원화와 적은 인력으로 관리됨에 따라 낮은 수준의 평가 결과가 나타나게 되었습니다. 특히, C부서의 경우 병원 수익과 직접적이고 최종단계업무로서 수가 착오, 청구 지연 등으로 인해 수익의 손실 발생 개연성을 감안하여 요양급여 적정성 평가업무는 조정할 필요가 있습니다.

[표 3] 의료질 평가 결과 현황

구분		등급	@@병원		!!병원		##병원		\$\$병원		%%병원	
			16년	15년	16년	15년	16년	15년	16년	15년	16년	15년
의료질 평가	의료 질평가 환자안전 등	5단계	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	교육수련	3단계	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	연구개발	3단계	3	2	3	3	3	3	3	3	-	-

이에 따라 의료질평가 결과에 따른 의료질평가지원금 수입을 2015년, 2016년 수가 기준과 2015년 진료인원으로 추정해보면 [표 4]와 같이 2015년 1,787백만원, 2016년 3,121백만원 상당으로 추정되지만 등급간의 수가 차이가 확대 추세임을 고려할 때 평가등급 향상을 위한 노력이 요구됩니다.

[표 4] 의료질평가지원금 추정 수익

(단위 : 천원)

구 분	합계	@@병원	!!병원	##병원	\$\$병원	%%병원
2015년	1,787,254	1,088,222	195,523	209,989	186,573	106,947
2016년	3,121,014	2,421,982	195,523	209,989	186,573	106,947

나. 감염관리에 관한 사항

5개 병원은 감염예방을 위해 감염관리업무에 대해 [표 5]과 같이 운영 하고 있습니다.

[표 5] 5개 병원 감염관리 운영 현황

(단위: 명)

구분		@@병원	!!병원	##병원	\$\$병원	%%병원
소속부서		A부	F실	G실	H실	F실
인원	의사	검무	-	검무	검무	검무
	간호사	2명(간호5급)	1명(간호4급)	1명(간호5급)	1명(간호5급)	1명(간호5급)
간호사근무연수		3년5월/1년9월	1년2월	2년9월	6월	4년7월
비 고						감염전문간호사

※ ##병원 간호사 1명 검무

「의료법」 제47조 및 「의료법 시행규칙」 제43조, 제46조에 따르면 병원 감염 예방을 위해 감염관리실을 설치하여야 하고 감염관리업무를 수행하는 전담 인력을 두어야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 2015년 메르스 사태이후 정부에서는 감염관리에 대한 정책을 지속적으로 강화하여 다인실 및 음압병실 설치 기준을 변경하도록 「의료법 시행규칙」 개정을 추진하고 있으며, 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 일부개정(보건복지부 고시 제2016-152호)」에 의하면 2016년 09월부터 감염예방·관리료가 종합병원의 경우 입원환자 1일당 1등급 2,380원, 2등급 1,950원을 산정할 수 있도록 신설되었습니다.

[표 6] 감염예방·관리료 수가 산정 기준

구분		1등급	2등급
일반사항		감염관리실을 설치하여야 함.	
인원수	의사	분기별 병상수 대비 300:1 이하	분기별 병상수 대비 300:1 이하
	간호사	분기별 병상수 대비 150:1 이하	분기별 병상수 대비 200:1 이하
인력 기준	의사	- 월평균 주20시간 이상 감염관리실 업무 수행 - 감염내과 전문의 또는 소아청소년과 감염분과 전문의 - 감염관리실 근무경력 1년 이상, 감염관리에 대한 24시간 이상 교육 이수	
	간호사	- 감염관리 전담간호사 1명 이상은 감염관리 자격증 보유 또는 감염관리실 근무경력 3년 이상자	

그런데, 5개 병원 감염관리에 관한 실태를 확인한 결과, 「직제규정」 제10조 [별표 1-2]부터 [별표 1-6]까지 병원의 기구표에 감염관리실 조직이 없으며, [별표 3] 부서별 업무분장에도 감염관리실의 분장업무가 없으며, 「직제규정 시행세칙」 제4조 [별표 4] 부서별 업무분장에서도 @@병원을 제외한 4개 지방병원은 감염관리에 대한 업무가 누락되었으며, [표 7]과 같이 감염예방·관리료 산정 기준수 대비 의사 7명, 간호사 8명이 부족한 것으로 확인되었습니다.

[표 8] 감염관리 전담인력 기준 인력(2등급) 및 운영실태

(단위: 명)

구분		합계	@@병원	!!병원	##병원	\$\$병원	%%병원
의사	기준	11	3	2	2	2	2
	현원	4	1	-	1	1	1
	부족인원	△7	△2	△2	△1	△1	△1
간호사	기준	14	3	3	3	3	2
	현원	7	2	1	1	1	1
	부족인원	△8	△1	△2	△2	△2	△1

5개 병원 감염관리 전담인력 2등급 충족 시 2015년 입원환자 실적을 적용하면 [표 9]과 같이 19억 원상당의 추가 수익이 기대할 수 있습니다.

[표 9] 감염예방·관리료 2등급 충족시 수익 예상

(단위: 명/원)

구분	합계	@@병원	!!병원	##병원	\$\$병원	%%병원
진료인원	980,422	335,218	165,615	187,082	165,255	127,252
단가	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
수익예상	1,911,822,900	653,675,100	322,949,250	364,809,900	322,247,250	248,141,400

4. 조치할 사항

○ QQ이사(RR부)는

- ‘가’항 의료질평가(적정성평가)와 ‘나’항 감염관리는 공단 중장기 4대 전략 목표인 ‘新경영혁신으로 의료품질 향상’의 48개 실행과제와 부합되는 사항이며, 병원의 위상 강화 및 수익창출을 고려하여 TT실과 협의하여 전담부서설치 및 인력 확보와 업무분장, 위임전결 등을 적극 검토하여 주시기 바라며,(권고)

○ WW이사(YY부)는

- ‘가’항 의료질평가(적정성평가)는 중장기적으로 인력충원, 시스템 개선 등을 통해 총괄·통합관리할 수 있는 컨트롤타워 형식의 일원화된 전담부서 설치 및 인력 확보를 검토하여 주시고, ‘나’항 감염관리는 정부정책 이행 및 수익창출을 고려하여 전담부서 설치 및 인력 확보에 대해 ◎◎부와 적극적으로 검토하여 주시기 바라며,(권고)

○ 5개 병원장은

- ‘가’항과 ‘나’항에 대해 병원의 역량 및 위상 강화와 수익창출을 위해 본사와 협업으로 조직 및 정원확보와 자체 인력 조정 등을 통해 의료질평가(적정성평가) 및 감염관리가 중장기적·체계적으로 관리될 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다.(권고)